1. Primeiros socorros em emergência — salvar uma vida até chegar ajuda

Guia Oracle OS. Baseado nas diretrizes IFRC 2025, ERC (Conselho Europeu de Ressuscitação), OMS/CICV "Basic Emergency Care" e CICV "First aid in armed conflicts" (ver acervo, com ilustrações: "IFRC International First Aid Guidelines", "US Army TC 4-02.1 First Aid", "SOBRASA ABC dos Primeiros Socorros", "MSF Clinical guidelines", "Hesperian Where There Is No Doctor"). Isto não substitui formação: faça um curso de primeiros socorros quando puder.

Ordem de prioridades

1. **Segurança**: não se torne mais uma vítima (trânsito, fogo, eletricidade, gás, água, estruturas instáveis).
2. **Pedir ajuda**: 112 (Europa), 999 (Reino Unido), 911 (EUA/Canadá), 192/193 (Brasil). Sem rede, mande alguém ou use rádio.
3. **Hemorragia grave** primeiro, depois **vias aéreas**, **respiração**, **circulação** (X-ABC).
4. Mantenha a vítima **quente**, calma e acompanhada. Anote horas e o que fez.

Paragem cardíaca — reanimação (RCP)

- Não responde e não respira normalmente (ou só "arfa") → é paragem. Ligue 112 em alta voz e peça um **DAE/desfibrilhador**.
- **Compressões**: centro do peito, mãos sobrepostas, braços esticados, **5–6 cm** de profundidade, **100–120 por minuto**, deixe o peito subir totalmente.
- Se souber e quiser: **30 compressões : 2 insuflações**. Se não, faça só compressões sem parar.
- Ligue o DAE assim que chegar e siga as instruções de voz.
- **Afogamento e crianças**: comece com **5 insuflações**, depois 30:2. Criança: comprimir 1/3 do peito (uma mão ou duas). Bebé: dois dedos, ~4 cm.
- Continue até a vítima respirar normalmente, chegar ajuda ou ficar exausto (troque a cada 2 minutos se houver outra pessoa).

Hemorragia grave

- **Pressão direta forte** sobre a ferida com pano limpo, durante pelo menos **10 minutos** sem espreitar. Se encharcar, ponha mais por cima.
- Feridas fundas (virilha, axila, pescoço): **encher a ferida** com gaze/pano e comprimir.
- **Garrote** (torniquete) só para hemorragia que ameaça a vida num braço ou perna e não para com pressão: 5–7 cm **acima** da ferida (não sobre articulação), apertar até parar o sangramento, **anotar a hora**, não soltar. Improvisado: tira larga (3–5 cm) + pau para torcer. Nunca fio fino.
- Deite a vítima, mantenha-a quente: risco de **choque**.

Choque (falta de circulação)

- Sinais: pálido, suores frios, pulso rápido e fraco, confusão, sede.
- Deite de costas, controle hemorragias, aqueça (manta por baixo e por cima), não dê comer nem beber se pode precisar de cirurgia. Ajuda urgente.

Engasgamento

- Consegue tossir → incentive a tossir.
- Não consegue tossir, falar ou respirar → **5 pancadas entre as omoplatas** (inclinado para a frente), depois **5 compressões abdominais** (Heimlich). Alterne.
- **Bebé**: 5 pancadas nas costas (de bruços no antebraço, cabeça mais baixa) + 5 compressões no peito com dois dedos. Nunca compressões abdominais em bebés.
- Fica inconsciente → RCP.

Inconsciente mas a respirar

- **Posição lateral de segurança**: de lado, perna de cima dobrada, cabeça inclinada para trás para a boca drenar. Vigie a respiração a cada minuto.
- Suspeita de lesão na coluna (queda, acidente): mantenha a cabeça alinhada e só mova se houver perigo ou se precisar de abrir a via aérea.

Queimaduras

- **Arrefecer com água corrente fresca 20 minutos**, o mais cedo possível (útil até 3 horas depois). Não use gelo, manteiga, pasta de dentes.
- Tire anéis, relógios e roupa não colada. Cubra solto com película aderente ou saco plástico limpo.
- Procure ajuda se: maior que a palma da mão da vítima, cara, mãos, pés, genitais, articulações, queimaduras químicas ou elétricas, crianças e idosos.
- Químicos: escovar pó seco e lavar com muita água 20+ min. Olhos: lavar 15–20 min com a pálpebra aberta.

Fraturas, entorses e luxações

- Imobilize **na posição em que encontrou**; tala a abranger a articulação acima e abaixo (paus, revistas, cartão, almofada). Verifique circulação (cor, calor, sensibilidade) depois de apertar.
- Fratura exposta: cubra com pano limpo, não empurre o osso para dentro, controle hemorragia.
- Entorse: repouso, frio (com pano), compressão, elevação.

Frio e calor

- **Hipotermia** (tremores, confusão, fala arrastada): abrigo, tirar roupa molhada, isolar do chão, manta/saco cama, cobrir a cabeça; bebidas quentes e doces **só** se estiver bem acordado. Grave (deixa de tremer, sonolento): manusear com muito cuidado, na horizontal.
- **Queimadura de frio**: não esfregar; reaquecer em água morna 37–39 °C só se não houver risco de voltar a congelar.

- **Golpe de calor** (quente, confuso, pode não suar): **arrefecer já** — imersão em água fria é o melhor; senão molhar e abanar, gelo no pescoço, axilas e virilhas. Ajuda urgente.
- **Exaustão pelo calor**: sombra, deitar, beber água ou soro.

Desidratação, diarreia e vómitos — soro caseiro (OMS)

- **1 litro de água segura + 6 colheres de chá rasas de açúcar + ½ colher de chá rasa de sal.** Mexer até dissolver. Prove: não deve ser mais salgado que lágrimas.
- Beber goles pequenos e frequentes, mesmo com vómitos. Crianças continuam a mamar/comer.
- Sinais de perigo: não urina há 8+ h, muito sonolento, olhos encovados, sangue nas fezes, bebé que não mama → ajuda médica.

Outras emergências comuns

- **Reação alérgica grave (anafilaxia)**: inchaço da boca/garganta, falta de ar, manchas → **adrenalina autoinjetável** na coxa (por cima da roupa), 112, deitar com pernas levantadas (ou sentado se custa respirar). Segunda dose após 5 min se não melhorar.
- **Asma**: sentar direito, inalador azul (salbutamol) — 1 puff a cada 30–60 s até 10 puffs.
- **Ataque cardíaco** (dor no peito que irradia, suores, náusea): sentar, 112, se adulto e não alérgico **mastigar 300 mg de aspirina**.
- **AVC — teste FAST**: cara descaída, braço fraco, fala alterada → tempo: 112 já, anote a hora.
- **Hipoglicemia** (diabético confuso, suado): se consegue engolir, 15–20 g de açúcar (sumo, açúcar, rebuçados); repetir após 15 min.
- **Convulsão**: afastar objetos, almofadar a cabeça, não segurar nem pôr nada na boca; depois posição lateral. Mais de 5 min → ajuda.
- **Envenenamento**: não provocar vómito; guardar a embalagem; queimaduras na boca → pequenos goles de água.
- **Mordida de cobra** (víbora na Europa): repouso total, imobilizar o membro, tirar anéis, hospital. Não cortar, não chupar, não garrote.
- **Feridas**: lavar com muita água limpa (ou fervida e arrefecida) e sabão à volta; tirar sujidade; cobrir. Infeção (vermelhidão a alastrar, pus, febre) → antibiótico/médico. Tétano: vacina em dia.
- **Mordeduras de animais**: lavar 15 minutos com água e sabão (raiva); procurar ajuda.

Parto de emergência

- Deixe acontecer naturalmente; mãos limpas; apoie a cabeça do bebé sem puxar.
- Seque o bebé, pele com pele com a mãe, cubra ambos. Se não respira: secar e esfregar as costas; se continuar, 5 insuflações e RCP de bebé.

- Não tenha pressa a cortar o cordão: espere 1–3 min, ate em dois pontos e corte entre eles com lâmina limpa/fervida. A placenta sai sozinha em até 30–60 min; guarde-a para ser vista. Hemorragia forte depois: massajar o útero pela barriga e amamentar.

Muitas vítimas — triagem rápida (START)

- **Anda?** → VERDE (aguarda).
- Não respira mesmo depois de abrir a via aérea → PRETO (falecido/sem esperança com os recursos atuais).
- Respira mais de 30/min → VERMELHO (imediato).
- Pulso radial ausente ou preenchimento capilar > 2 s → VERMELHO.
- Não cumpre ordens simples → VERMELHO. Caso contrário → AMARELO (pode esperar um pouco).
- Só pare para abrir via aérea e parar hemorragias graves; reavalie sempre.

Kit de primeiros socorros mínimo

Luvas, compressas e ligaduras, pensos, fita adesiva, garrote, manta térmica, tesoura, pinça, soro fisiológico, sabão, paracetamol/ibuprofeno, anti-histamínico, sais de reidratação, termómetro, medicação habitual da família para 2+ semanas, lista de alergias.